

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	運送病人之作業標準 The Operational Performance Standards Transporting Patients				
編號	A31000-Q02-W-F07	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	95 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 4.7 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解運送病人之流程及重要性，以確保病人之安全。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

本作業標準參照醫療品質暨病人安全委員會制定 212020-000-W-001 病人院內運送標準作業流程。

（一）運送病人

1. 適用對象（病人）：凡至本院就診或住院之病人需運送時，均適用。

成人病人定義：>18 歲；兒科病人定義：≤18 歲。

2. 適用時機：

(1) 病人在院內因接受侵入性檢查、治療、手術及轉換床位，必須運送至其他單位。

(2) 檢查、治療或手術結束欲送回原單位。

(3) 經醫師評估需要進行運送安全交班之病人。

3. 不適用時機：

(1) 各科之單位內運送檢查。

(2) 急診 X 光檢查於同樓層。

(3) 門診病人。

(4) 同樓層病人之運送檢查如：N10 樓 ENT 檢查的病人，N11 樓、N16 樓進行超

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	2/10

音波檢查。

(5) 汝川大樓 8 樓 IR、NI、PI 病人互轉。

(6) 產房或手術室新生兒至兒科各單位(BR、IR、NI、PI)。

(二) 確認病人情況分級（由醫師判定）：依據醫療品質暨病人安全委員會

212020-000-W-001 之分級原則，區分為 A、B、C 等分級標準。

(三) 運送前聯繫：先與接收單位確定時間。

(四) 運送前病人情況評估：醫師需於運送前評估運送等級、病況及隨同人員及必要設備、給氧裝置及攜帶設備，再由轉出單位/護理人員於運送安全交班系統執行醫囑並勾選特殊交班、管路或裝置與其他選項，確認後即可進行病人運送。

(五) 護理人員於運送前，需確認運送日期及目的，並評估病人生命徵象意識狀況，若病人生命徵象不穩定，應與醫師討論目前運送的迫切性與可行性。

(六) 「病人運送安全評估」說明如下（必要時由負責醫師和護理人員共同完成以下確認）：

1. 去程及回程運送前評估病人情況（運送前先依病人情況分成 A、B、C 等級，其各等級，其各所需的器材設備、隨同運送人員及交通管控等如表一所示）。
2. 與接收單位的交班與溝通：A、B 級病人的運送，負責醫師和護理人員均應進行單位間的交班，並確定病人到達時可立即進行檢查或治療。
3. 去程及回程運送前，確認下列事項：
 - (1) 確認病人（詢問病人姓名及另一項基本資料並核對手圈）。
 - (2) 確認呼吸道通暢，若需要抽痰的病人，運送前需先完成抽痰後再運送。
 - (3) 確認各管路之通暢與位置，並固定妥善。
 - (4) 確認病人生命徵象穩定。
 - (5) 應向病人或家屬解釋目的、檢查項目、治療過程及注意事項。
 - (6) 運送設備需做測試，確認所有功能是正常的及儲備電量充足。
 - (7) 確認運送中使用藥品的量足以供應整個運送過程，例如：升壓劑、點滴、氧氣等。

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	3/10

(8) O₂ 供應量必須足夠運送行程，再加上 30 分鐘預備量（若 O₂ 供應量不足時應至就近單位緊急借用）。

(9) 經醫師評估需要或有使用呼吸器重症患者，評估 FiO₂ ≥ 60% 或 PEEP ≥ 10 cmH₂O，則由呼吸治療師共同陪同運送。

(七) 由負責醫師做運送所需人員與設備的判斷，轉出單位/護理人員負責運送設備的準備與確認。

(八) 醫師勾選為 A、B 級者，須由轉出單位/護理人員確認病人運送日期、轉出時間、接收單位、正滴注中藥品及管路或設備後，依醫師確認所需之設備，進行氧氣桶存量、血氧監測儀功能、心跳及血壓監測儀功能、IV Pump 功能、管路、靜脈輸液是否足夠、急救箱、Ambu bag 及 Mask 等物品之檢視與功能確認進行運送。檢查或治療結束後，欲轉回原單位或前往下一個單位時，由轉出單位/護理人員確認身上管路及儀器設備功能是否完整與正確以及交班事項後，方可進行轉送。

(九) 醫師勾選為 C 級者，由轉出單位/護理同仁確認病人運送日期、轉出時間、接收單位，確認正滴注中的藥品及檢查身上管路後，由傳送人員陪同至接收單位。檢查或治療結束後，欲轉回原單位或前往下一個單位時，由轉出單位/護理人員確認身上管路及儀器設備功能是否完整與正確以及交班事項後，方可進行轉送。

(十) 病人接受侵入性檢查、治療、手術後，欲轉回原單位或前往下一單位時，A、B 級由主護護理師確認氧氣桶存量、血氧監測儀功能、心跳及血壓監測儀功能、IV Pump 功能、管路、靜脈輸液足夠、急救箱、Ambu bag 及 Mask 等物品之檢視與功能確認，並進行運送。C 級則由轉出單位進行確認，傳送人員進行運送。

(十一) 病人接受檢查、治療後，檢查單位須將交班事項書寫完整，以利交班。若於檢查單位發生異常事件，請進行異常事件通報並主動以電話通知原單位。

(十二) 轉出及接收單位完成病人及設備確認後，需輸入「接收時量測生命徵象數值」。若運送等級改變，則需由醫師重新評估病人狀況，並於系統上勾選等級改變重新開始運送安全交班流程。

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	4/10

- (十三) 若該次運送為單程，運送結束後，由去程接收單位輸入「接收時量測生命徵象數值」，並點選結案「已完成運送交班（後續已無運送行程）」。
- (十四) 若需運送精密醫療儀器如：呼吸器、電擊器等，請通知傳送人員協助運送。
- (十五) 運送過程中，應密切注意呼吸道（尤其是人工氣道）及各種管路通暢性、點滴輸注情形及病人情況變化。若遇急救或突發狀況，應儘速將病人送往鄰近單位進行搶救或啟動 9595，若已送達檢查單位，則留在檢查單位進行搶救並以 9595 流程廣播救援。
- (十六) 運送病人各人員職責規範說明
1. 若運送之病人，經醫師評估為 A 級則需由醫師、護理人員或專科護理師陪同轉送，並視病人狀況評估是否需要呼吸治療師或傳送人員陪同。
 - (1) 醫師職責：站於病人側邊觀察病人狀況及監視系統生命徵象變化（如：生理監視器）確認運送過程中是否需要做緊急處置。（監視系統應懸掛穩定，若無法懸掛原則置放於床尾）。
 - (2) 護理人員/專科護理師職責：站於病人側邊觀察病人狀況，協助運送病人並確認運送目的地路線及過程環境安全。
 - (3) 呼吸治療師職責：壓擠 Ambu Bag、觀察氧合狀況及運送目的地之呼吸器調度與設定。
 - (4) 傳送人員或其他協助者職責：站於病人床頭或床尾，負責推送病人及儀器，並確認運送目的地路線及過程環境安全。
 2. 若運送之病人，經醫師評估為 B 級則由護理人員或專科護理師陪同轉送，並視病人狀況評估是否需要呼吸治療師或傳送人員陪同。
 - (1) 護理人員/專科護理師職責：站於病人側邊觀察病人狀況及監視生命徵象變化（如：生理監視器），協助運送病人並確認運送目的地路線及過程環境安全。遇有病人危急，應立即聯絡醫師，且必要時，得先行給予緊急救護處理。
 - (2) 傳送人員或其他協助者職責：站於病人床頭或床尾，負責推送病人及儀器，確認運送目的地路線及過程環境安全。

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	5/10

(3) 呼吸治療師職責：壓擠 Ambu Bag、觀察氧合狀況及運送目的地之呼吸器調度與設定。

3. 若運送之病人，經醫師評估為 C 級則由傳送人員陪同。

(1) 傳送人員或其他協助者職責：引導病人運送目的地路線，並注意環境安全。

(十七) 再次確認注意事項如下：

***運送前：**

4. 若有使用氧氣設備者需評估是否有痰液，必要時須先抽痰後再運送，以維持呼吸道通暢。
5. 選擇合適的運送工具如:輪椅、推床、大床，並確認其功能正常。
6. 使用推床時需拉起床欄，使用輪椅者評估是否需要給予保護性約束，以防病人跌落或受傷。
7. 床上 IV stand 及儀器需固定妥當，避免跌落之意外發生。

***運送中（前往目的地）：**

1. 密切生命徵象（尤呼吸道）變化、維持各種管路通暢性。
2. 需注意病人安全，若遇急救或突發狀況應儘速啟動 9595。

(十八) ***運送回（達）單位（接受檢查、治療、手術後）：**

1. 運送單位依病情，必要時需事先電話交班特殊事件並填寫交班紀錄。
2. 主護護理人員確認病人生命徵象及管路通暢。

(十九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	6/10

六、參考資料

- (一) 醫療品質暨病人安全委員會制定之病人院內運送標準作業流 212020-000-W-001。

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	7/10

七、附件

表一：病人情況分級。

分級	病人情況	器材設備	運送者	交通管控
A 級	成人 (>18歲): - 生命徵象不穩定 (1) SpO₂ < 90% (使用 O₂ 後) (2) SBP < 70 或 MAP < 50 mmHg (3) 使用維生設備 (例: 呼吸器含 Ambu bag、葉克膜、IABP) 2. 使用升壓藥或強心劑 (SBP < 90 或 MAP < 60 mmHg) 3. CPR 後 ROSC 病人 4. 活動性出血且生命徵象不穩定 5. 急性心肌梗塞且生命徵象不穩定 6. 其他 小兒 (≤18歲): - 生命徵象不穩定 2. 使用維生設備 (例: 呼吸器含 Ambu bag、葉克膜、IABP) 3. 活動性出血且生命徵象不穩定 4. CPR 後 ROSC 病人 5. 使用升壓藥或強心劑 (SBP 低於此年齡之正常下限) 6. 其他	必備設備包括: 1. Ambu Bag+Mask 2. 足量 O₂ 筒 3. 攜帶式生理監視器或血氧濃度監測儀 選擇設備包括: 1. 急救箱 (急救藥物) 含 Bosmin、Atropine、Valium 2. 電擊器 3. IV PUMP 4. BP monitor	必要人員 1. 醫師 2. 護理人員或專科護理師 隨同人員 (可選) 1. 呼吸治療師 (醫師評估需要或呼吸器重症病人 FiO₂ ≥ 60% 或 PEEP ≥ 10 cmH₂O) 2. 傳送人員	使用專用電梯運送
B 級	1. 生命徵象不穩定且未達 A 級 (1) 使用鎮靜藥物有呼吸抑制之風險 (2) 意識改變躁動不安, 但無插氣管內管者 (3) 24 小時內曾接受長時間手術 (大於 12 小時) (4) 24 小時內曾意識喪失或急救者 (5) 24 小時內拔除氣管內管 (6) 有活動性出血 (7) 呼吸器無法脫離需下轉另一個單位 2. GCS 降低分數 ≥ 2 分 3. 麻醉恢復之病人 4. 急性心肌梗塞且生命徵象穩定 5. 其他	選擇設備包括: 1. Ambu Bag+Mask 2. 足量 O₂ 筒 3. 攜帶式生理監視器 4. 血氧濃度監測儀 5. 急救箱 (急救藥物) 含 Bosmin、Atropine、Valium 6. 電擊器 7. V PUMP 8. BP monitor	必要人員 (可選) 1. 護理人員或專科護理師 隨同人員 (可選) 1. 呼吸治療師 (醫師評估需要或呼吸器重症病人 FiO₂ ≥ 60% 或 PEEP ≥ 10 cmH₂O)、 2. 傳送人員	使用專用電梯運送
C 級	情況穩定欲接受檢查或手術, 目前無特殊症狀者。	選擇設備包括: 1. 足量 O₂ 桶 2. 其他	傳送人員	不需

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	8/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
95.04.30	1.0	新制定	95 年 04 月 30 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.10.05	3.0	整合 A31000-Q02-W-F07_運送病人之作業標準及 A31000-Q02-W-F08_單位間病人運送須知，重新修正。	100 年 10 月 05 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.26	4.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.04	4.1	新增第六項參考資料	104 年 08 月 04 日 護理部照護標準委員會通過
105.06.07	4.2	1. 新增第三項第(三)目之 1.2.3 填寫時機：針對病人分級評估表或交班單。 2. 修改病人轉送交班單（編號：212020-000-F-001）。 3. 第六項新增參考資料。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準委員會通過
106.05.10	4.3	1. 更修：原(一)運送病人適用時機：1.入院時。2.檢查（前後）。3.轉床時。4.手術（前後）。 2. 增修：（一）運送病人 修改：*適用對象（病人）、*適用時機 增加：*不適用時機： 3. 更修(三)說明 增加：105/10/17董事會通過O2供應預備量由20分鐘改為30分鐘 (8)O2供應量必須足夠運送行程，再加上30分鐘預備量（若O2供應量不足時應至就近單位緊急借用）。	106 年 05 月 10 日 護理長會議決議通過
107.06.29	4.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	4.4	1. 第三項第一至十九目說明內容文字修訂：將轉送改成運送。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過；

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	9/10

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第三項第二十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第四項使用表單刪除：兒科病人轉送安全評估表。 4. 第五項流程圖文字修訂：將轉送改成運送並刪除「兒科病人轉送安全評估表」。 5. 第七項附件修訂病人情況分級表。	108 年 06 月 12 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.08.18	4.5	依「醫療品質暨病人安全委員會_212020-000-W-001 病人院內運送標準作業流程」內容修訂。 1. 新增第三項第一目之 2(3)。 2. 第三項第五目修訂說明內容並刪除「兒科病人運送安全評估表」生命徵象狀況。 3. 第三項第九目刪除醫師勾選為 A、B 級者，或「兒科病人運送安全評估表」 4. 新增第三項第十五、十六目。 5. 更新附件一表格。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	4.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.08.04	4.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.01.09	4.6	依「醫療品質暨病人安全委員會_212020-000-W-001 病人院內運送標準作業流程」內容修訂。 1. 新增第三項第一目之 3.不適用時機。 2. 因電子化刪修部分內容。 3. 更新第六項參考資料。 4. 更新第七項附件表格。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過；112 年 12 月 20 日護理長會議通過；113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.09.03	4.7	依『醫療品質暨病人安全委員會_212020-000-W-001_病人院內運送標準作業流程』內容修訂。 1. 修訂第三項第一目之 3.不適用時機。 2. 新增第三項第十六目運送病人各人員職責規範說明。 3. 修訂第七項表一病人情況分級。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。

主題名稱	運送病人之作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F07	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
114.08.07	4.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	